

# L'ŒSOPHAGE

## I-INTRODUCTION

L'appareil digestif est composé de trois compartiments :

- la cavité buccale
- le tube digestif proprement dit : de l'œsophage à l'anus
- les glandes annexes principales : les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Elles sont localisées à l'extérieur du tube digestif, élaborent des sécrétions entrant dans le tube digestif par des canaux excréteurs

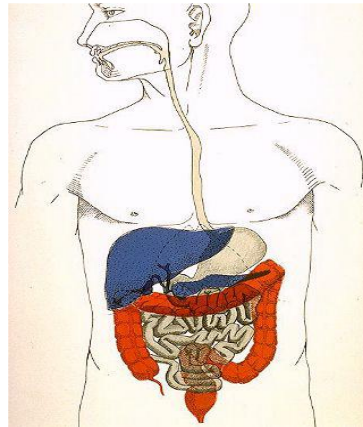


Fig. 1 : Schéma des différents segments du tube digestif

Sur le plan histologique, le tube digestif est constitué de **5 tuniques** concentriques, plus ou moins bien individualisées selon les segments considérés, qui sont de l'intérieur (la lumière) vers l'extérieur, la muqueuse, la musculaire muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, et une tunique conjonctive externe qui est soit une adventice, soit une séreuse.

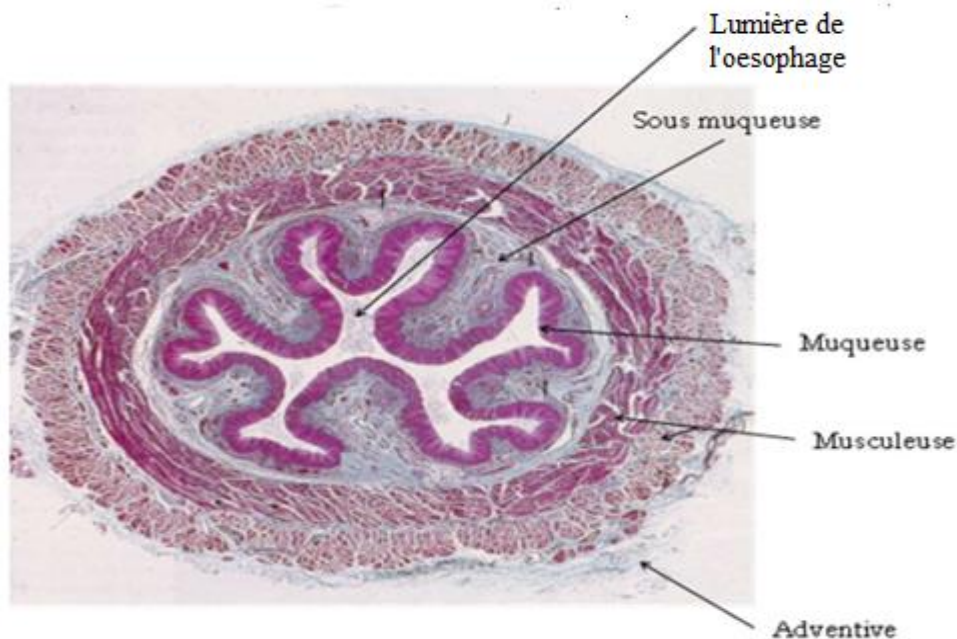


Fig. 2 : Aspect en MO d'une coupe transversale de l'œsophage

## 2-GENERALITES

L'œsophage est un conduit musculaire qui fait suite au pharynx et s'abouche dans l'estomac au niveau du cardia. Il véhicule les aliments fragmentés non encore digérés. Il mesure 20 à 25cm de long

## 3- STRUCTURE HISTOLOGIQUE

On retrouve les caractéristiques histologiques constitutives des 5 tuniques du tube digestif, avec une muqueuse, une musculaire muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et une adventice

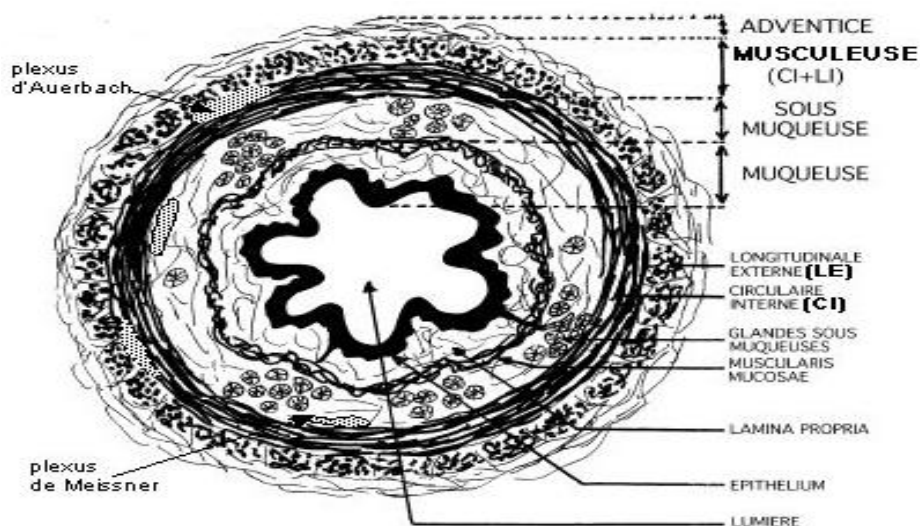


Fig. 3 : coupe transversale de l'œsophage

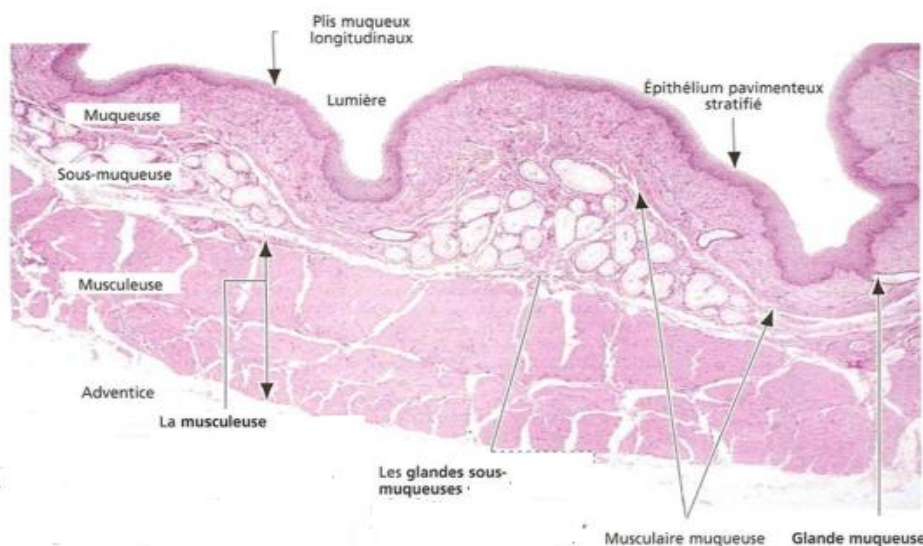


Fig. 4 : Aspect en MO de la paroi œsophagienne (faible grossissement HE)

### 3-1-La muqueuse

Est composée d'un épithélium et d'un chorion

#### 3-1-1- L'épithélium

L'épithélium pavimenteux, stratifié non kératinisé, très résistant, de type épidermoïde.

Il forme des replis qui s'effacent au passage du bol alimentaire. Le renouvellement de l'épithélium se fait à partir des cellules de l'assise germinative.

Des terminaisons nerveuses intra-épithéliales sont retrouvées et sont mises en évidence par des colorations d'imprégnation argentique.

#### 3-1-2- Le chorion

C'est un chorion papillaire, formé de tissu conjonctif lâche, dans lequel on rencontre des vaisseaux, des nerfs et des éléments lymphoïdes (**GALT**). On y trouve des glandes tubuleuses muqueuses, réparties en deux groupes :

- \* à l'extrémité supérieure : les glandes de Schaffer (inconstantes).
- \* à l'extrémité inférieure : les glandes cardiales.

### 3-2- La musculaire muqueuse (*Muscularis mucosae*)

Quelque fois absente dans la partie supérieure,

Elle est formée de fibres musculaires lisses, surtout longitudinales et elle est très développée à l'extrémité inférieure de l'œsophage

### 3-3- La sous-muqueuse

Elle est formée de tissu conjonctif plus ou moins dense contenant de nombreux éléments vasculaires, lymphatiques et nerveux (Plexus de Meissner).

Dans le tiers inférieur, on trouve quelques glandes œsophagiennes proprement dites, de nature muqueuse, ce sont des glandes tubulo-acineuses, contournées, ramifiées et lobulées les canaux excréteurs de ces glandes débouchent à la surface de l'épithélium

### 3-4- La musculuse

Elle présente une structure complexe du fait du caractère volontaire et involontaire de la déglutition.

En effet les fibres musculaires lisses et striées sont intimement entremêlées sur toute une portion de l'œsophage:

- Le 1/3 supérieur est fait de fibres striées
- Le 1/3 moyen est fait de fibres striées et lisses, ces dernières se substituant progressivement aux striées.
- Le 1/3 inférieur est fait de fibres lisses.

Les faisceaux musculaires striés et /ou lisses se disposent en deux couches:

- Une couche circulaire interne.
- Une couche longitudinale externe.

Entre les deux plans de la musculuse, sont réparties des fibres amyéliniques et des fibres myéliniques qui se terminent, dans le tiers supérieur de l'organe.

### 3-5- L'adventice

Formé de tissu conjonctif plus ou moins lâche, non délimité, qui rend l'œsophage solidaire des organes environnant. Couche cellulaire mal délimitée avec de nombreux adipocytes, des vaisseaux sanguins et lymphatiques

## 4 -HISTOPHYSIOLOGIE DE L'ŒSOPHAGE

L'œsophage est un organe **vecteur et propulseur** du bol alimentaire.

La progression du bol alimentaire fait intervenir pour les liquides la pesanteur, pour les solides le péristaltisme de la musculature et la lubrification par les sécrétions des glandes œsophagiennes.

## 5 –PATHOLOGIE

L'œsophage peut être le siège :

- D'affections congénitales : malformations (atrésie de l'œsophage avec ou sans fistule œsotrachéale, sténose, duplication)
- D'affection inflammatoires : œsophagite, hernie hiatale, varices œsophagiennes, reflux gastro-œsophagien (RGO)
- D'atteintes accidentelles : perforations, corps étrangers
- Trouble moteur = Achalasie : dû à l'absence de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage. cette anomalie empêche donc la progression des aliments vers l'estomac.
- D'affection tumorales : tumeurs bénignes ou malignes

### 2.3 La musculuse :

Elle est constituée de 2 plans : circulaire interne et longitudinal externe, mais sa composition varie suivant le niveau.

- Dans le tiers supérieur, les fibres musculaires sont striées. Elles prolongent celles des muscles pharyngés, responsables de la déglutition volontaire.
- Dans le tiers moyen, des fibres lisses se substituent progressivement aux fibres striées.
- Dans le dernier tiers, la musculature est lisse.

Entre les 2 plans de la musculuse existent des formations nerveuses analogues au plexus d'Auerbach intestinal (fibres amyéliniques) et, dans le 1/3 supérieur, quelques fibres myélinisées.

A l'extrémité inférieure de l'oesophage, le tonus des fibres lisses est important et réalise un véritable "sphincter physiologique", s'opposant au reflux gastrique.

### 2.4 L'adventice :

C'est une tunique fibreuse aux limites peu nettes et abondamment infiltrée de graisse. Elle est parcourue par les vaisseaux et les nerfs de l'organe.

### 3. HISTOPHYSIOLOGIE :

L'oesophage permet la progression rapide du bol alimentaire depuis la cavité buccale jusqu'à l'estomac grâce à l'élasticité de la sous-muqueuse, aux contractions péristaltiques de la